

2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

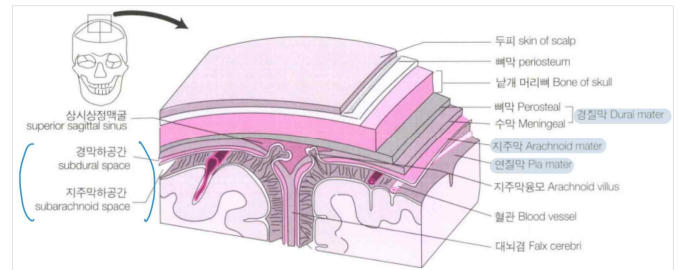
☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- 회색: 참고만 하면 되는 내용
- 하늘색형광펜☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

7. 뇌막

[뇌막]

- 정의: 뇌를 보호하는 구조 중 하나
 - * 뇌 보호 구조: 두피, 두개골, 뇌척수액, 뇌막
- 분류: 경막 + 지주막 + 연막
- 손상 시: 뇌를 압박하여 장애를 일으키고
경막외출혈, 경막하출혈, 지주막하출혈 등 유발 가능



↳ 경막하공간: 경막 아래 공간

지주막하공간: 지주막과 연질막 사이

[경막외 / 경막하 / 지주막하출혈 비교]

손상 부위	경막외출혈(EDH)	경막하출혈(SDH)	지주막하출혈(SAH)
특징	뇌막동맥 • 빠르게 뇌를 압박하며 주로 급성 → 동맥출혈이므로 빠르게 압박 • 환자 본인이 언제부터 증상이 나타났는지를 명확하게 말할 수 있음	정맥 • 서서히 뇌를 압박하며 주로 만성 (급성도 있긴 함) • 환자 본인이 언제부터 증상이 나타났는지 명확히 모름 → 과거력, 현병력을 꼼꼼하게 체크할 것	뇌동맥류의 파열 or 외상 • 격렬한 두통, 사출성 구토, 뇌수막자극징후 등
출혈 양상	✓ 출혈이 생겼을 때는 그 부분이 하얗게 보임 (density: 음영) └ 급성 출혈: 훨씬 하얗게 (high density) └ 만성 출혈: 덜 하얗게 (low density)		
	볼록렌즈 모양	초승달 모양	
→ CT상 차이를 알기 (어떤 출혈이고 어떤 특징이 있는지)			

8. 척수

구성	표부 백질 + 중심부 회백질 (cf - 대뇌: 세포체가 겉에 있기 때문에 겉이 회백질)
신경주행	전(前)각으로 운동신경이 나오고 / 후(後)각으로 감각신경이 들어옴
신경로 별 감각 담당	• 척추 시상로: 온도각, 통각 담당 / • 후주로: 위치각, 전동각 담당
신경 개수	총 31쌍: 경추신경 8쌍(C1위에서도 하나 나옴), 흉추신경 12쌍, 요추신경 5쌍, 천골신경 5쌍, 미골신경 1쌍

9. 신경로(상행/하행)

<신경로 이름의 의미>

○○△△로: ○○에서 시작하여 △△로 끝나는 신경로

[상행신경로] 감각신경 → 뇌 (위로 가는 신경로) / **감각** 담당

↳ 척수소뇌로, 후주로, 척수시상으로

	척수소뇌로	후주로 ☆	척수시상으로 ☆
경로	척수 → 바로 소뇌로 들어감	심부감각 위치각, 진동각 → 감각신경절 → 척수 동측 후주 → 연수에서 교차 → 시상, 대뇌피질 ⇒ 연수에서 반대쪽으로 신경이 갈아타며 시냅스 형성, 이후 시상에서 시냅스 형성하고 대뇌피질로 전달함	표재감각 온도각, 통각 → 감각신경절 → 척수 반대측에서 교차 → 후주시상, 대뇌피질 ⇒ 척수 반대측으로 교차하면서 시냅스를 형성(바로 교차한다는 게 후주로의 차이!!), 올라가서 시상에서도 시냅스를 형성
교차 (여부 및 위치)	X	O (연수에서 교차)	O (감각신경절(척수 반대측)에서 교차)
손상 시	소뇌 병변: 동측 장애 (신경이 교차 없이 소뇌로 들어가므로) → 균형잡기 X (걸을 때로 예를 들면, 오른발 디딜 때마다 휘청거린다면 이건 오른쪽 소뇌의 문제인 것)	어느 위치(레벨-높이)가 손상되느냐에 따라서 심부감각과 표재 감각이 모두 손상될 수도 있고, 둘 중 하나만 손상될 수도 있음 ex) 시상에 문제 有 → 심부/표재 감각 모두 문제	
시냅스 위치		연수, 시상	감각신경절, 시상

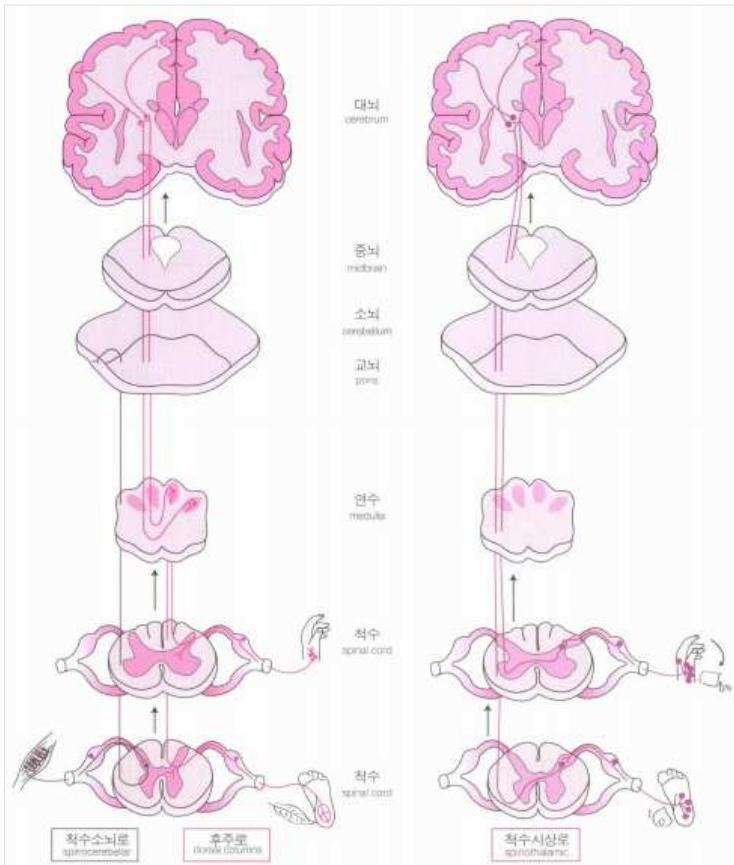
[하행신경로] 뇌 → 운동신경 (아래로 가는 신경로 _ 수의근을 움직이게 함)

= **운동** 담당

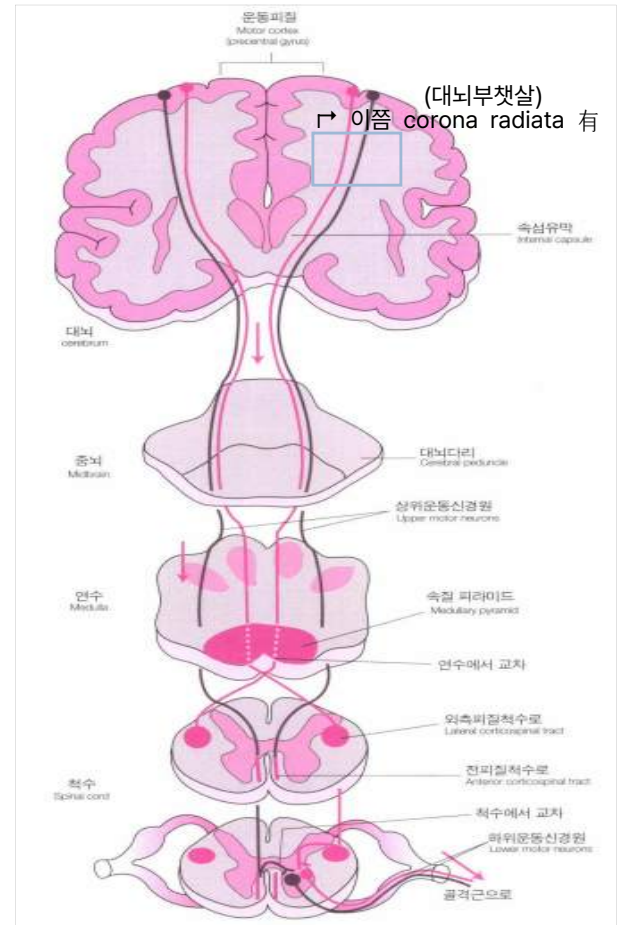
<피질척수로(= 척수로)> ☆

- 경로: 대뇌피질 → 대뇌부챗살, 내포의 후(後)각
→ 추체로 → 연수에서 **교차** → 척수의 운동신경절

<경로별로 어딜 거치는지, 시냅스 위치, 교차 여부 (도식적으로 이해), 교차 위치>를 아래 그림 참고 해서 이해하기



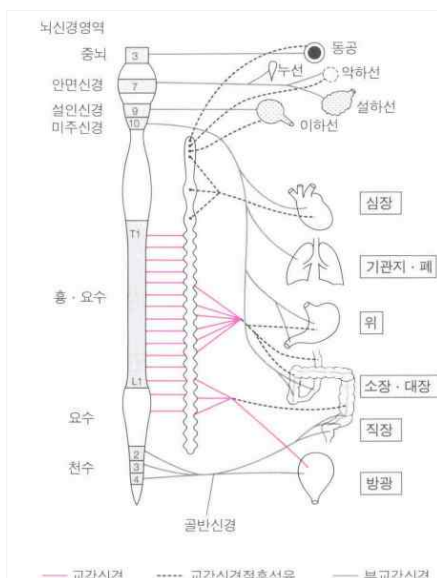
[그림 1-29] 상행신경로



[그림 1-30] 하행신경로

10. 자율신경

- 기능: 불수의적인 구조물 심장, 평활근, 분비샘을 지배하는 신경계
- 특징: 체성신경계와 반대 개념
- 구분: 교감신경계 / 부교감신경계



	기능	특징
교감신경	동공 확대, 혈관 수축 배뇨 억제, 포도당 방출	Fight or Flight → 위급상황에 대처하기 위해 작동
부교감신경	교감신경과 반대	Rest and Digest → 심장박동 억제, 소화기관 자극, 배뇨 촉진

- 자율신경 실조: 불안, 초조, 강박 등의 정신 증상, 전신권태, 피로, 미열, 식은땀, 조열, 안면홍조, 소화불량, 구역, 구토, 빈뇨 등 여러 가지 다양한 증상
- 한의학적 관점: 심화항염, 기체기울로 인한 화열증, 기허증 등으로 치료
↳ 한의학적 내용과 양방 내용이 완전히 들어맞진 X

↳ 3, 7, 9, 10번 뇌신경, 천추 부위: 부교감신경 지배 | 흉, 요추 부위: 교감신경 지배

11. 뇌신경(12개)

- 종류: 운동성, 감각성, 혼합성
- 특징: 시각, 청각, 후각 같은 특수감각 등을 포함하고 있기 때문에 척수신경보다 복잡함 → 뇌의 말초신경
⇒ 어떤 뇌신경의 손상이나에 따라 증상 多

번호	명칭	영어	성질	기능	기원	세부 사항
1	후각신경	olfactory	감각	후각	비강 상부	
2	시신경	optic	감각	시각	간뇌	• 주로 뇌의 후두엽과 관련됨 (눈알은 정상이어도 후두엽에 문제가 있으면 보고 있는 걸 해석하지 못함)
3	동안신경 ☆	oculomotor	운동	안구운동, 동공수축	중뇌	• 상직근, 내직근, 하직근, 하사근 = 안구운동 • 상안검거근 = 눈꺼풀을 들고 닫기 ex) 안검하수: 동안신경 문제일 수 O
4	활차신경	trochlear	운동	내측 하방 보기	중뇌	• 상사근 = 내측 하방 보기
5	삼차신경 ☆	trigeminal	혼합	씹기, 얼굴/혀 감각	교뇌	• 운동성 저작근, 악이복근, 악설골근 = 씹기
						• 감각성 얼굴/혀의 온도, 촉각 통각 ex) 삼차신경통: 얼굴 통증
6	외전신경	abducent	운동	바깥쪽 보기	교뇌	• 외직근 = 바깥쪽 보기
7	안면신경 ☆	facial	혼합	표정, 미각	중뇌	• 운동성 안면근육 = 얼굴 표정 짓기
						• 감각성 혀 앞 2/3 미각 +) 침샘, 눈물샘 분비
8	내이신경	vestibulo cochlear	감각	평형감각, 청각	중뇌	• 내이신경 = 전정와우신경 └ 전정신경 ^{안뜰신경} : 평형감각 └ 와우신경 ^{달팽이신경} : 청각
9	설인신경 ☆	glosso pharyngeal	혼합	연하 기능, 미각	연수	• 운동성 연하 기능
						• 감각성 혀 뒤 1/3 미각 → 혀는 운동, 감각을 담당하는 신경 이 다름 (감각은 부위별로도 다름)
10	미주신경	vagus	혼합	연하, 발성 내장/근육 감각	연수	+) 귀밑 침샘 분비
						• 운동성 인두, 후두 근육 = 연하/발성
11	부신경	accessory	운동	목 근처 근육	연수	• 감각성 내장기관 ^{심장, 호흡기} , 근육 감각
12	설하신경	hypoglossal	운동	혀 운동	연수	• 입술의 근육, 흉쇄유돌근, 승모근 • 혀 운동

[안구운동을 하게 하는 외안근 6개의 신경지배] LR6 SO4 AO3 (Lateral Rectus 6 Superior Oblique 4 All Others 3) ☆

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3번 뇌신경(동안신경) 지배 <ul style="list-style-type: none"> └ 내직근(안쪽곧은근) Medial Rectus └ 상직근(위곧은근) Superior Rectus └ 하직근(아래곧은근) Inferior Rectus └ 하사근(아래빗근) Inferior Oblique | <ul style="list-style-type: none"> • 4번 뇌신경(활차신경) 지배 <ul style="list-style-type: none"> - 상사근(위빗근) Superior Oblique • 6번 뇌신경(외전신경) 지배 <ul style="list-style-type: none"> - 외직근(가쪽곧은근) Lateral Rectus |
|--|--|

제2절

순환 · 신경내과학의 증상

의식과 정신상태

1. 의식의 정의

[의식] 자기 자신이나 사물에 대해 인식하는 작용

• 특징

- └ 환자 평소 지남력 상태, 경도인지장애 or 치매의 유무를 알고 있어야 확인 가능
- └ 환자와 대화를 통해 알 수도 있으나, **정밀한 검사를 통해서도 파악 + 환자 보호자를 통해서도 알 수 있음**

<시간, 장소, 사람에 대한 지남력 검사>

① Glasgow Coma Scale

Eyes open(E) 눈을 뜨는 반응	Spontaneously	자의적으로 눈을 뜨다.	4
	To speech	음성명령에 의해 눈을 뜨다.	3
	To stimulus	통각에 의해 눈을 뜨다.	2
	None	반응 없음	1
Best verbal response (V) 언어반응	Orientated	지남력 반응 정상	5
	Confused	혼란된 대화	4
	Inappropriate words	혼란된 단어	3
	Incomprehensible sounds	이해 할 수 없는 음성	2
	None	반응 없음	1
Best motor response (M) 운동반응	Obey commands	명령에 따른 반응	6
	Localise stimulus	국소적 통증자극에 대한 운동반응	5
	Flexion-withdrawal	통각에 대해 회피성 굴곡반응만 나타남	4
	Flexion-abnormal	통각에 대한 팔꿈치의 굴곡반응	3
	Extension	통각에 대해 팔꿈치의 신전반응	2
	No response	반응 없음	1

└ 눈을 뜨는 반응: Eye Open(E)

└ 언어 반응: Best verbal response(V)

└ 운동 반응: Best motor response(M)

⇒ 이 3가지 검사 항목 정도만 기억☆

② MMSE-DS

1. 올해는 몇 년도입니까?	0	1
2. 지금은 무슨 계절입니까?	0	1
3. 오늘은 며칠입니까?	0	1
4. 오늘은 무슨 요일입니까?	0	1
5. 지금은 몇 월입니까?	0	1
6. 우리가 있는 이곳은 무슨 도/특별시/광역시입니까?	0	1
7. 여기는 무슨 시/군/읍/면입니까?	0	1
8. 여기는 무슨 구/동/읍/면입니까?	0	1
9. 우리는 지금 이 건물의 몇 층에 있습니까?	0	1
10. 이 건물의 이름이 무엇입니까?	0	1
11. 제가 세 가지 물건의 이름을 말씀드리겠습니다. 공짜로 다 들으신 다음에 세 가지 물건의 이름을 모두 말하며 보십시오. 그리고 몇 분 후에는 그 세 가지 물건의 이름을 다시 물어볼 것이지나 들으신 물건의 이름을 잘 기억하고 계십시오. 나무, 자동차, 모자	0	1
12. 100에서 7을 빼면 얼마가 됩니까? 거기에서 7을 빼면 얼마가 됩니까? 거기에서 7을 빼면 얼마가 됩니까? 거기에서 7을 빼면 얼마가 됩니까? 거기에서 7을 빼면 얼마가 됩니까?	0	1
13. 조금 전에 제가 기억하려고 말씀드렸던 세 가지 물건의 이름이 무엇인지 말씀하여 주십시오. 나무, 자동차, 모자	0	1
14. (실제 시계를 보여주며) 이것을 무엇이라고 합니까? 15. (실제 연필을 보여주며) 이것을 무엇이라고 합니까?	0	1
16. 지금부터 제가 말씀드리는 대로 해 보십시오. 한 번만 말씀드릴 것이지나 잘 듣고 따라 하십시오. 제가 종이 한 장 드릴 것입니다. 그러면 그 종이를 오른손으로 받아, 반으로 접은 다음, 무릎 위에 올려놓으십시오. 오른손으로 받는다. 반으로 접는다. 무릎 위에 놓는다.	0	1
17. (검정 오각형 그림을 가리키며) 여기에 오각형이 그려져 있는 그림이 있습니다. 이 그림을 아래 빈 곳에 그대로 그려보십시오.	0	1
18. 무슨 색 빨간색이 있습니까?	0	1
19. "피를 모아 태산"은 무슨 뜻입니까?	0	1
총 점	/30	

← 실제 환자들이 지남력이 떨어졌을 때 쉽게 적용해볼 수 있고
일차적으로 적용해야 하는 검사 (시술자에 따라 검사 결과가 다를 수도 있기도 함)

* 주의: 12번 문항

→ 100-7을 85라고 대답했다면

오답이므로 해당 부분에서는 점수 X,

다시 -7을 했을 때 78이라고 대답하면 점수 O

- 임상에서는 환자가 의식을 잃은 것 같다고 하는 느낌인지, 실제 의식을 상실했는지 명확히 구분해야 함 (발병 당시 상황에 대해 주의 깊게 병력 청취하기)

→ 의식 상실의 경우 원인을 알아보기 ① 대뇌반구의 기능적 장애

② 뇌간 병변으로 망상 활성화 체계가 정상 작동하지 않아 구심성 자극이 대뇌까지 도달 X

③ ①+② 두 가지 모두의 결과

[다양한 의식 상태] ✓ 대략적인 특징 정도만 알아두기

종류	특징			
Alert ☆ (명료)	• 자발적으로 눈을 뜨고 명령에 적절한 반응 ⇒ 일반적인 건강한 사람 • 의식이 깨끗하고 정상적인 상태			
Drowsy ☆ (병리적 기면)	• 작은 자극에 눈을 뜨지만 바로 수면 상태에 빠짐 • 자발적인 운동과 언어가 가능, 명령에 적절한 반응 ┌ 그럼에도 계속 눈을 감는.. (조는 것과 구분해야 함) └ • 내장과 방광 기능은 정상			
Stupor ☆ (혼미)	• 자발적인 운동 있음 • 명령에 적절한 반응을 하지 않음 ⇒ 엉뚱하게,,, • 통증 자극에 각성이나 국소적, 혹은 회피 반응을 보이는 상태			
	자발적 운동	통증 자극에 대한 반응	내장과 방광의 자동조절 기능	심부건반사, 각막반사, 대광반사
Semicoma ☆ (반혼수)	X	有 (반사적인 굴곡 혹은 신전반사)	소실	존재
Coma (혼수)		無		소실
Confusion ☆ (혼돈)	• 지남력이 소실된 상태 • 기면이나 흥분상태 • 감각 자극에 잘못된 판단을 하고 주의 집중기간이 단축됨			
Delirium (섬망)	• 지남력 소실이나 감각 자극의 인식에 이상			
Hypersomnia (과수면)	• 수면 증가 상태 • 깨어있는 동안에도 주의력 감소 • pathologic drowsiness			
Akinetic mutism (무운동함구증)	• 명료한 상태처럼 보이나 자발적 운동이 없으며 정신활동이 없음 • 망상활성계의 부분적 장애에 의한 특유의 의식장애			
Locked in syndrome (감금증후군)	• 언어나 동작에 의한 의사소통이 불가능함 • 뇌간부의 양측성 핵상마비, 안구 수직 운동은 가능 • 의식은 명료함			
Chronic vegetative state (만성식물상태)	• 심한 뇌손상 후 혼수 시기를 지나 이차적으로 발생함 • 수면과 각성 및 자율신경 기능 정상임 • 생명징후는 보존되나 정신기능의 활동성은 존재하지 않음			
Brain death (뇌사)	• 모든 뇌기능의 소실(평탄뇌파), 호흡 정지, 모든 뇌간 반사의 소실			

2. 의식 상실의 원인

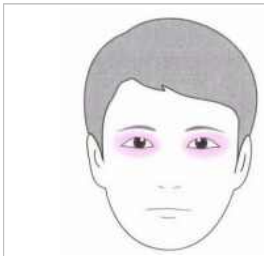
[일시적인 경우] → 뇌로 가는 혈류가 원활 X or 간질 히스테리 등으로 나눌 수 있음

- 결증
- 정확한 진단: 환자, 보호자, 목격자가 환자의 의식 상실 전, 중, 후 상황을 말할 시간을 충분히 주어 병력 청취
- 원인: 아래 표 참고

[지속적인 경우]

- 원인: 뇌 망상활성체계 or 뇌피질 or 뇌 전반적 장애
- 의식 상실 상태로 내원 시 체크할 사항

① 외상 징후



[Raccoon's sign]

: 눈 주변 안와 점상출혈



[Battle's sign]

: 귀 뒤 유양돌기 쪽

② 활력 징후: 혈압, 체온

③ 수막자극징후, 안저검사

- 2차 손상 우려 시: 혈압검사, 24시간 혈압 모니터링 검사, 심전도, Holter monitoring, 심초음파, 기립 경사도 검사, 동맥혈 가스분석검사, 혈당검사 등 실시
- 기립 경사도 검사: 환자를 눕힌 상태에서 기립시키면서 혈압 등이 어떻게 변하는지 확인
- 환자 안정 치료 & 교육: shock position = 증상 시 심혈류량 늘려 증상이 빨리 회복되게 하는 자세
↳ 눕히는 것

<일시적인 경우> ① 혈액이 부족해서 생기는 경우

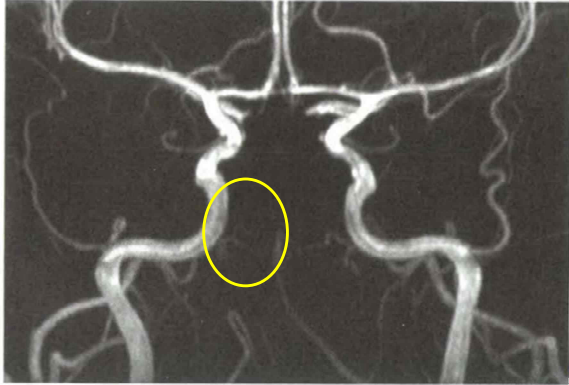
종류	발생 기전(원인)	다발	증상	그 외 특징	검사 및 치료 / 환자 교육
신경심장성 실신☆	• 혈관미주신경성 • 혈관운동신경억제	• 사람 많거나 기온 높은 환경 • 음주 • 지나친 피로 • 심한 통증 • 배고픔 • 오래 서 있는 경우 • 스트레스 많은 환경	<실신 전> 위약, 구역, 발한, 어지러움, 시야 흐려짐 ⇒ 수초~수분 간 실신 전 증상 종종 선행 - 이런 실신 전 증상이 있었는지 꼭 확인	• 정상인들도 경험하며 모든 실신의 약 반수 • 누워있는 자세에서의 실신은 드물 → 누운 자세는 혈류 공급이 원활하므로 • 의식 소실의 정도와 기간이 다양하며 자주 반복됨	<기립경사대 검사> 자율신경이상 여부 등을 검사
			<의식 잃기 직전> 두근거림		<혈관미주신경성 실신일 때> 발병 당시 머리를 낮게 하여 심장혈류량을 증가시켜야 의식을 빠르게 회복할 수 있음
			<이후> 맥박/혈압↓, 얼굴 창백		
			<후유증> 대부분 X, but 지속적인 무박동과 저혈압 이면 신체 장애		
기립저혈압	• 뇌로 가는 혈류량 감소로 실신 → 노인 실신의 주요 원인 → 혈관운동성반사가 불안정, 만성적인 결함이 있는 환자들에게서 발생	• 교감신경계에 영향을 주는 고혈압제 or 여러 항우울제 약물 복용 환자들 → 약물이 원인이면 약물치료 중지 or 대체 약품 사용 (약을 많이 먹는 환자는 특히 유의할 것)	<동반 증상> 가벼운 두통, 위약이나 피로, 집중력↓, 흐린 시야, 떨림, 창백, 불안, 두근거림, 오심	<진단 기준>☆ 기립 1분 후(~3분 이내) 수축기 혈압 20mmHg 또는 확장기 혈압 10mmHg 이상 낮아지는 경우 (기립 경사대 등을 이용하여 안전하게 검사하는 것이 필요)	<환자 교육> 빠르게 이동 or 일어나기 X 서서히 자세 이동 O (warming up 개념) 압박스타킹 등을 이용
심장부정맥	* 실신의 원인이 자세하게 알려지지 않은 모든 경우에 생각될 수 있음 • 빠른 or 느린 부정맥 → 심박출량 불충분 → 대뇌 관류 불충분 → 의식 유지 X	• 중장년 허혈성 심질환 과거력 cf) 자세와는 관련 無	<의식 상실 전> 어지러움을 느끼는 경우 多 <의식 상실 시> 안색의 뚜렷한 변화, 맥박 소실, 심박동 불규칙, 심전도에 허혈, 전도 장애, 리듬장애		<검사 & 치료> 심전도, Holter monitoring 검사로 부정맥을 찾고 치료

종류	발생 기전(원인)	의심해볼 상황	증상	특징
과호흡	이산화탄소가 혈중으로 빠져나와 혈관을 강하게 수축 자극하면서 발생 <증상 악화 기전> 스트레스 → 과호흡 → 불쾌감 → 불안 → 더욱 심한 과호흡 → 증상 악화 및 실신 <회복> 호흡 규칙적, 혈중 가스 정상적 → 대뇌혈류량 정상화 → 의식 회복	- 젊은 여성 - 불안한 상태 - 의식 상실 발생 전 호흡의 힘들음 호소 - 사지 원위부 지각 이상 - 수족 경련 관찰 시	어떨어떨함 느끼며 의식 없음	- 과호흡 증상은 자발적 과호흡 시에도 유발 可 - 종이봉투를 입에 대고 재호흡하면 회복 可 ⇒ 쉽게 회복될 수 있음

<일시적인 경우> ㉔ 좋지 못한 혈액이 가는 경우 (blood no good)

종류	발생 기전(원인)	증상	특징
저산소증	- 무의식 장애를 일으키는 매우 드문 원인 - 사고로 호흡이 정지되어 뇌에 산소공급이 되지 않았을 때 발생할 수 있음 ex) 기절놀이, 급성 심근경색, 익사		천식발작과 같은 심한 호흡장애가 나타나는 환자에게도 의식이 대부분 남아있음 ↳ 저산소증 유발 O
저혈당증	- 당뇨병 환자 - 경구 혈당 강하제 - 인슐린 과도하게 사용 - 끼니를 거른 경우 - 운동을 과도하게 한 경우	[아드레날린 분비와 관련되어 있음] - 심계/정충 - 진전, 식은땀, 졸림, 흐린 시야 - 오한, 오심 - 불안, 이상행동 및 착란 - 심한 경우 의식 상실	- 확진: 발작 시 혈당 농도를 측정하여 확진 - 대처: 당뇨 환자가 저혈당증으로 발한, 언어 장애 호소 시 빠르게 사탕, 주스 등으로 혈당 공급

<일시적인 경우> ㉓ 그 외

종류	발생 기전(원인)	특징
척추기저동맥 순환부전으로 인한 일과성 허혈발작 (TIA) ☆	<의심할 수 있는 상황> - 중장년 이상에서 심근경색, 협심증, 중풍, 간헐적 파행 등 동맥질환을 가지고 있거나 뚜렷한 색전의 제공처가 있는 경우 ↳ 심장에서 생겨 뇌혈관을 막은 것 - cf) 혈전: 그 자리에서 생긴 것 - 일과성 허혈발작의 과거력이 있는 자가 의식 상실이 있는 경우	<증상> 의식 상실에 기여 <확진 & 치료> 뇌혈관 조영술을 통하여 확진 후 중풍(뇌경색)에 준하여 치료  [그림 2-9] 뇌기저동맥(basilar artery)이 폐색된 모습 (조영제가 통과하지 못하는 것으로 파악)
뇌전증	교통사고나 중풍으로 측두엽 손상인 경우에도 발생 O	<구분> ▮ 전반성 발작: 비정상적인 전기 방전이 뇌간 상부에서 시작 - 순식간에 양측 대뇌반구로 퍼짐 ▮ 부분 발작: 뇌의 일정 부분에 국한 <주의할 점> 뇌전증 환자는 평소에 약을 잘 복용해야 하며, 자주 발생 시 혈액 내 약물 농도 검사를 실시해야 함
히스테리 발작	정신적인 원인으로 갑자기 의식 상실	- 사춘기나 청소년기에 잘 나타남 - 가끔 사지&얼굴 경련을 수반하기도 함 - 발작하는 동안 기억이 없으며 자기 몸을 조절하지 못했던 기억만 함

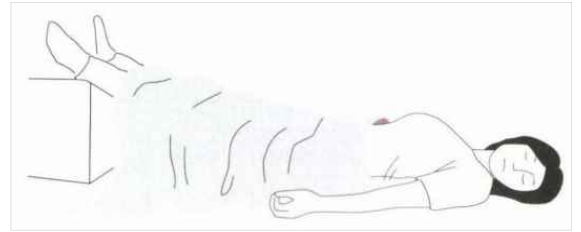
3. 의식 상실 환자의 처치

- ① 원인을 파악하기 위한 노력
- ② 기도를 확보
- ③ 몸을 압박하는 것을 제거하고

④ shock position (누운 자세)

↳ 뇌로 가는 혈류량을 높이기 위해 머리를 낮추고 다리를 높임

ex) 침훈: 치료 중단, shock position 취하기 (의식 상실 예방 차원)



[그림 2-10] shock position

* 일시적인 경우라고 해도 적절한 처치를 받지 못하거나 기질적 병변이 있는 경우

→ 지속적인 의식상실, 혼수로 갈 수도 있음 ★ 그래서 처치는 중요 ★

4. 의식 상실의 예후

일시적인 의식 상실	후유증 X, 정상적으로 회복됨 ⇒ 이정도가 한의원에서 볼 수 있는 정도
지속적인 의식 상실	대뇌구조의 비가역적 손상에 의한 것 = 회복 어려움
깊은 혼수 + 인공호흡장치 + 뇌간의 심한 손상	자발적인 회복 호흡이 어려울 때 = 예후 극히 불량
소리에 대한 반응에도 눈 못 뜬 언어 구사 X, 통증 자각 X	예후가 좋지 못한 편 (이러한 상태가 6시간 이상 지속되는 환자 중 50% 이상은 사망, 극소수만 회복)